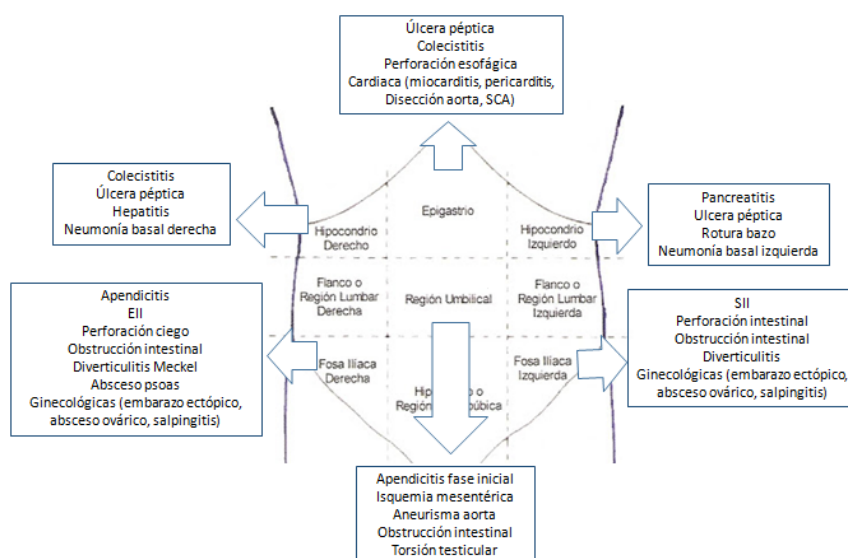


GASTRITIS Y EPIGASTRALGIA EN URGENCIAS

Victoria Isabel Cano López, Rudiger Carlos Chávez Flores.

INTRODUCCIÓN

El **dolor abdominal** es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el servicio de urgencias hospitalarias, estando localizado en **epigastrio** en un **25%** de los casos. Este síntoma abarca un **amplio diagnóstico diferencial**; por lo que su aproximación diagnóstica en urgencias muchas veces supone un reto.



Causas principales de dolor abdominal agudo

En ocasiones, la epigastralgia está relacionada con la **dispepsia**, que se define como cualquier síntoma procedente del tracto gastrointestinal superior (reflujo, epigastralgia, náuseas o hinchazón) de duración superior a **1 mes**. Las causas de origen digestivo más frecuentes son la **enfermedad por reflujo gastroesofágico** (ERGE) y la **enfermedad péptica ulcerosa** (25%). Fuera del tracto digestivo la causa más frecuente es el consumo de **fármacos** especialmente AINEs, corticoides y clopidogrel. Hasta en un 75% de los casos no se encuentra causa y se clasifica como **dispepsia funcional**.

DIAGNÓSTICO

La aproximación diagnóstica en estos pacientes en Urgencias debe comenzar con una correcta anamnesis y exploración física.

Síntomas de alarma
Pérdida de peso no intencionada
Vómitos recurrentes
Disfagia progresiva
Odinofagia
Signos de sangrado activo (melenas, hematoquecia, anemia)
Historia familiar de cáncer gástrico
Inicio brusco

Anamnesis

- Síntomas de alarma (Tabla 1)
- Antecedentes personales: fármacos, episodios previos similares, fecha última regla, alimentos ingeridos, síntomas dispépticos (hinchazón, saciedad precoz, plenitud postprandial, náuseas)
- Características de dolor: localización, carácter, intensidad, duración, con que mejora o empeora.
- Otros: Alteración del tránsito intestinal, vómitos, síntomas miccionales o ginecológicos, etc.

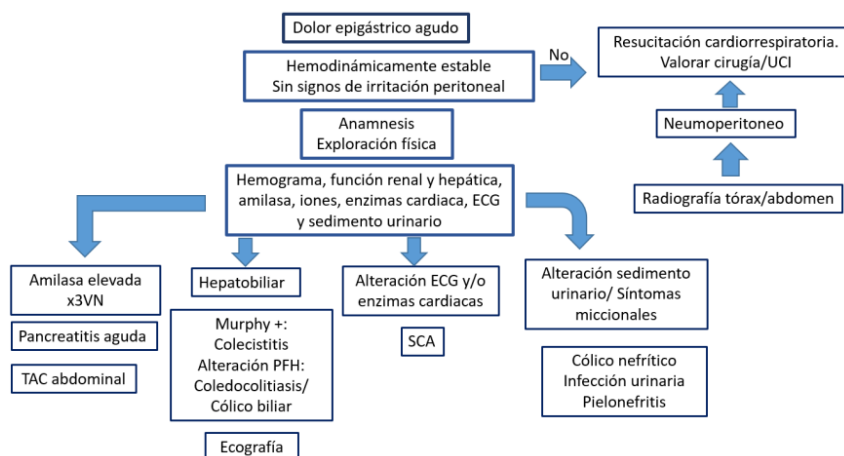
Exploración física

- **Inspección:** estado general. Constantes. Coloración. Distensión abdominal. Actitud del paciente. Cicatrices de cirugías previas. Hernias.
- **Auscultación:** los ruidos intestinales disminuidos o ausentes en caso de obstrucción evolucionada/íleo paralítico, aumentados en caso de diarrea o “metálicos” en caso de obstrucción de reciente comienzo.
- **Palpación:** signos de irritación peritoneal y masas.
- **Percusión:** timpanismo iría a favor de obstrucción/perforación y la matidez a favor de masas o ascitis.

Además sería recomendable una exploración cardiotorrespiratoria para excluir otras causas extradiigestivas del dolor.

Pruebas complementarias

- **Hemograma.**
- **Coagulación básica.**
- **Bioquímica.** Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, PCR. CK y troponina si sospecha de síndrome coronario agudo. LDH si sospecha de isquemia mesentérica.
- **ECG.** Descartar arritmias/IAM
- **Sistémico y sedimento de orina.** Si sospechamos cólico nefrítico/infección de orina.
- **Radiografías de tórax y abdomen.** Neumoperitoneo, obstrucción, calcificaciones pancreáticas o litiasis.
- **Ecografía abdominal.** En función de nuestra sospecha diagnóstica: patología hepatobiliar.
- **TAC abdominal.** Si no es concluyente los estudios previos o sospecha de obstrucción/perforación.



Algoritmo diagnóstico del dolor epigástrico agudo

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

- **Medidas generales:** Dieta absoluta, vía venosa periférica (2 en caso de hemorragia), SNG si obstrucción, antiéméticos (Metoclopramida 10mg iv u Ondasetron 4mg iv si obstrucción), analgésico y antibiótico si infección.
- Pacientes **menores de 50 años y sin síntomas de alarma:** IBP o ranitidina intravenoso u oral, los estudios no han demostrado diferencias significativas tanto la vía de administración como el fármaco utilizado. Alta domiciliaria con:
 - Cambios en el **estilo de vida** (abandono de tabaco/alcohol y evitar consumo AINEs)
 - **IBP** 4 semanas (Omeoprazol 20mg, Lansoprazol 30mg o Pantoprazol 40mg) antes de las comidas. Si ya tiene un IBP pautado, cambio por otro IBP.
 - **Procinético** (Levogastrol 25mg, 15 minutos antes de las comidas) si hinchazón o plenitud postprandial.
 - Derivar a Consultas Externas de digestivo para valorar infección por *Helicobacter pylori* y necesidad de otras pruebas complementarias.
- Pacientes **mayores de 50 años y con síntomas de alarma** serían candidatos a **endoscopia**. El personal de urgencias debe distinguir entre los pacientes que van a requerir una gastroscopia urgente o preferente (Figura 3).

Indicación de endoscopia

Endoscopia emergente (< 24horas)	Evidencia de sangrado digestivo con paciente inestable o antecedente de varices esofágicas.
Endoscopia urgente (1-7 días)	• Evidencia de sangrado digestivo o anemia con paciente estable. • Disfagia u odinofagia. • Síntomas de alarma.
Endoscopia electiva (> 7 días)	• Persistencia o progresión de síntomas dispépticos a pesar de tratamiento empírico. • Masa, estenosis o úlcera en pruebas de imagen. • Vómitos recurrentes. • Evaluación de pacientes con ERGE y manifestaciones extradigestivas. Cribado de esófago de Barrett (reflujo sintomático, raza blanca, obeso, varón, mayor de 50 años). • Síntomas recurrentes después de tratamiento quirúrgico antirreflujo.

Puntos clave

- No todo dolor epigástrico es benigno ni de causa digestiva. No olvidar descartar IAM o aneurisma aorta.
- La úlcera péptica puede ser una entidad benigna, pero puede tener graves complicaciones como la hemorragia digestiva, perforaciones u obstrucción.
- En la hemorragia digestiva una hemoglobina normal no indica seguridad. No transfundir pacientes estables. Tratamiento inicial IBP y gastroscopia.

BIBLIOGRAFÍA

- García Marín AM, Turégano Fuentes FJ, Cuadrado Ayuso M, Zaráin Obrador L. Dolor abdominal en Urgencias: abdomen agudo. 2015. Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 11(90):5357-5364.
- Robinson P, Perkins JC Jr. Approach to Patients with Epigastric Pain. Emerg Med Clin North Am. 2016;34(2):191-210.

- Rodríguez-Lago I, Cabriada, JL. Protocolo diagnóstico de la epigastralgia aguda. 2016. Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 12(2):92-95.
- Senay E, Eken C, Yildiz M, Yilmaz D, Alkan E, Akin M et al. Comparison of intravenous pantoprazole and ranitidine in patients with dyspepsia presented to the emergency department: a randomized, double blind, controlled trial. World J Emerg Med. 2016;7(1):30-4.
- Delaney B, Ford AC, Forman D, Moayyedi P, Qume M. Initial management strategies for dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev. 2005;4:CD001961.
- Mattu A, Chanmugam AS, Swadron SP, Tibbles C, Woolridge D, Marcucci L. Avoiding common errors in the emergency department. Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
- Marks D, Harbord M. Emergencies in Gastroenterology and Hepatology. Oxford:Oxford University Press;2013.